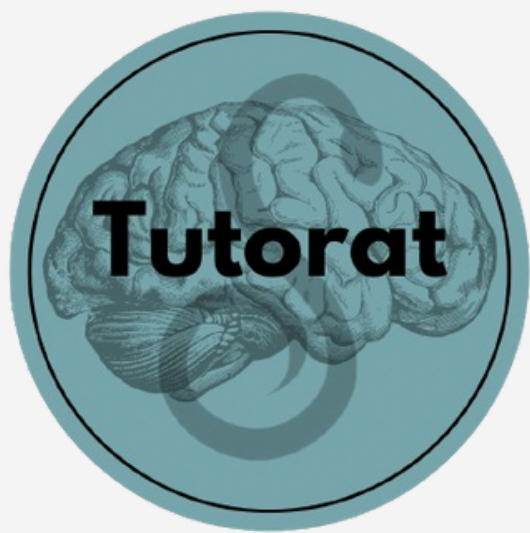


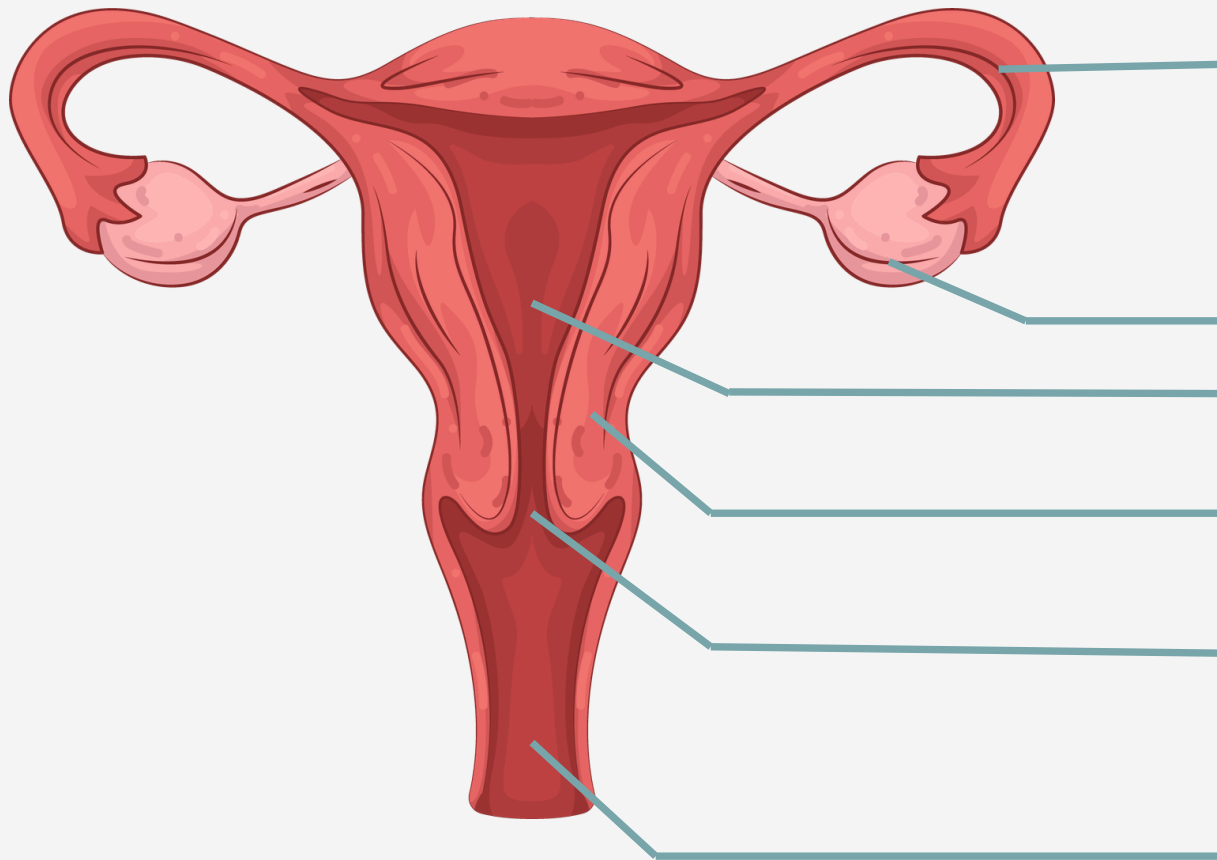
Systeme génital féminin



@CESIREVISE

Physiologie

Organe interne



Trompes de fallopes. Elle permettent l'acheminement des spermatozoïdes vers l'ovocyte et le déplacement de l'embryon vers la cavité utérine. C'est ici que la plupart des grossesses extra-utérines se déroulent.

Ovaires

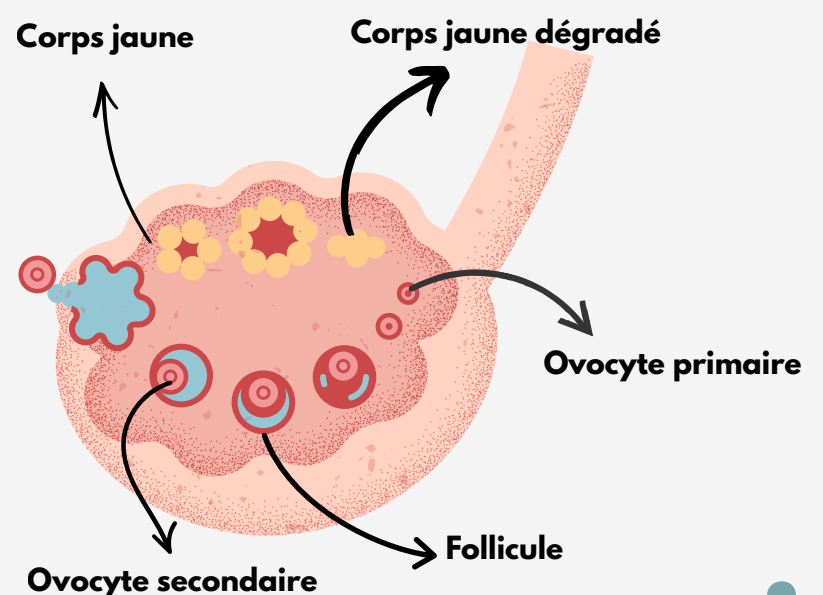
Lumière de l'utérus, il s'agit de la cavité, le "creux" de l'utérus où le conceptus va se développer.

Myomètre (muscle extérieur) et **endomètre** (muqueuse intérieure tapissant la cavité)

Col cervical, que l'on mesure pour déterminer le stade du travail lors de l'accouchement, ou le site des frottis par exemple.

Vagin, organe réceptacle du sperme, pour acheminer les spermatozoïdes vers l'utérus. Il possède une lumière fictive, il est en réalité constamment collabé.

Les ovaires contiennent les **ovocytes** en développement, entourés des **follicules**. Une fois que l'ovocyte sera éjecté, le follicule va se transformer en **corps jaune** qui va se dégrader.



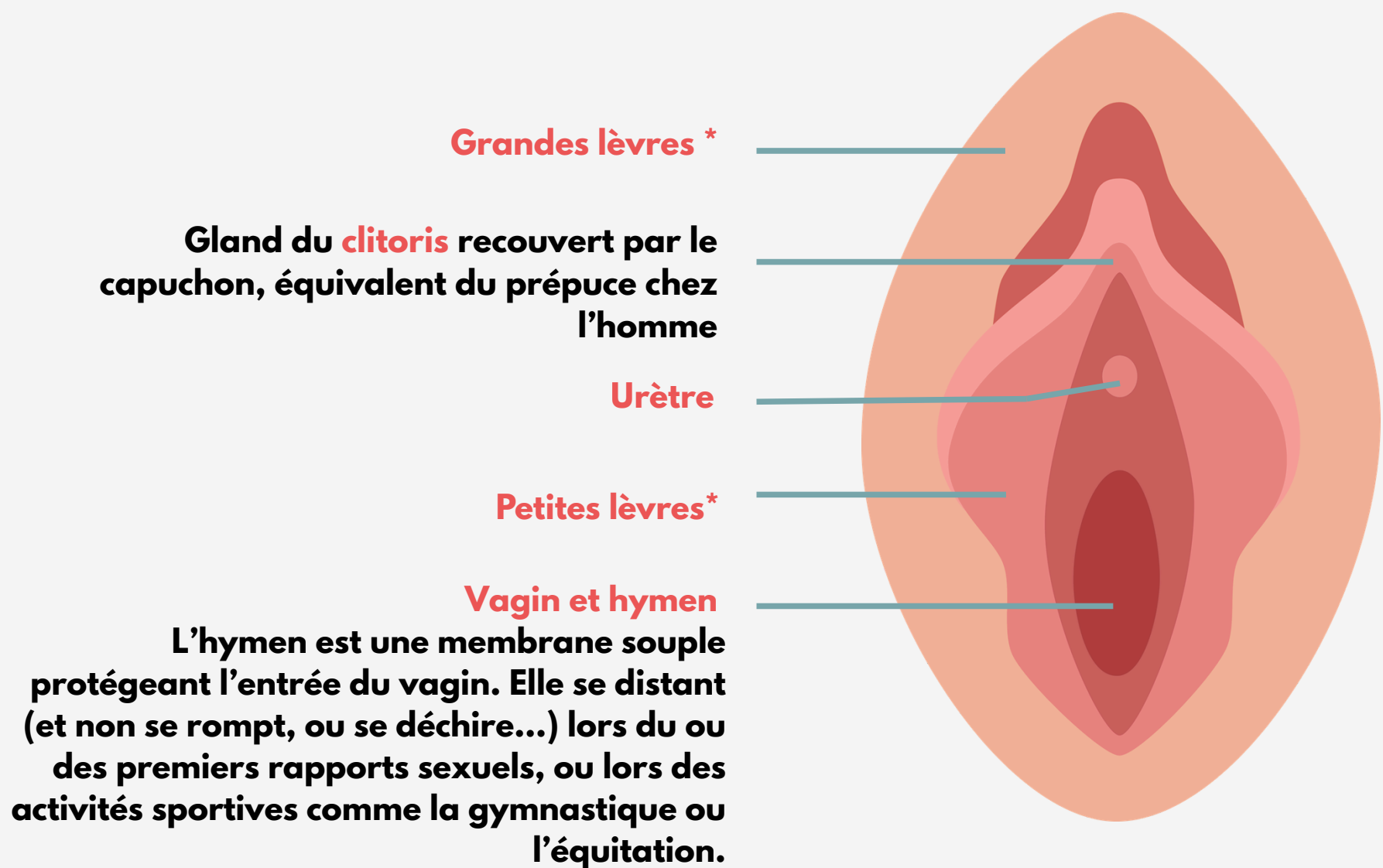
Tutorat

@CESIREVISE

Physiologie

Organe externe

La vulve est situé entre les jambes, à la face inféro-anterieur du **pubis**.
C'est un organe très **sensible**, permettant le **plaisir** lors de rapports sexuels, mais aussi le siège de nombreuses **douleurs**.



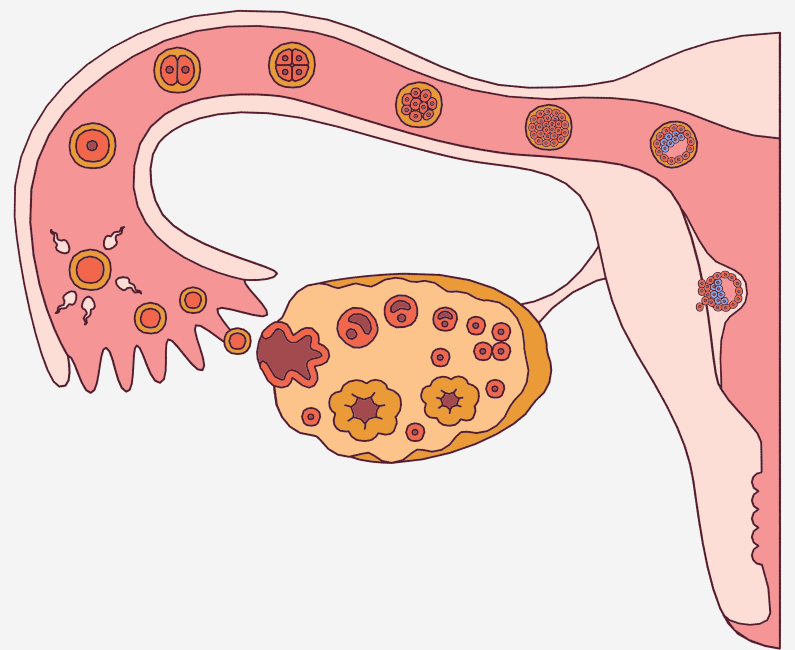
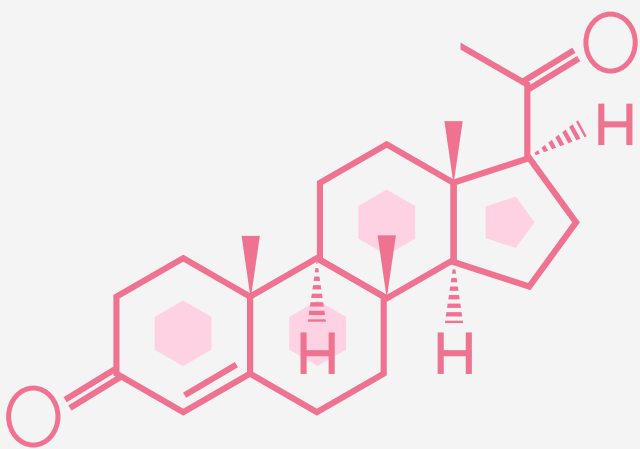
*Chez certaines femmes, les petites lèvres sont plus proéminentes que les grandes lèvres. L'anatomie est une **variabilité considérable** des gènes qui nous composent, et s'en est une ! La notion de petite ou grande est utilisé en repère.



Utérus et ovaires

L'utérus est un organe unique et symétrique de la femme, il est l'organe de la reproduction. Il est constitué d'un muscle appelé le **myomètre** (extérieur), et d'une muqueuse appelée **endomètre** (intérieur). Le col de l'utérus abouche sur le vagin.

À ses côtés, de part et d'autres, on distingue les trompes de fallopes reliant les ovaires à la lumière (cavité) utérine.



Les ovaires sont au nombre de deux et sont des glandes **amphicrines**, ils permettent la sécrétion d'hormones telles que **l'œstrogène** ou la **progestérone**, et l'excretion des **ovocytes** (ils deviennent ovules au moment où ils sont fécondés.). Ces deux hormones sont essentielles au bon fonctionnement du cycle menstruel et à la préparation d'une éventuelle grossesse.



Cycle menstruel

Le cycle menstruel dure environ 28 jours, mais cette période peut varier selon les femmes. 4 phases principales :

Menstruations : La première phase commence par le premier jour de règles, d'environ 7 jours. La muqueuse utérine se détache et sera évacuée sous forme de sang, provoquant les menstruations.

Folliculaire : un follicule se développe au sein de l'ovaire, l'endomètre s'épaissit, le taux d'oestrogène augmente .

Ovulation : L'ovaire délivre son ovule, et migre progressivement vers la trompe utérine. C'est le moment où la fécondation est le plus probable.

Lutéale : le follicule devient le corps jaune. L'endomètre se prépare à accueillir un embryon si fécondation. Le taux de progestérone augmente.

À la fin du cycle :

- S'il y a fécondation, l'embryon s'implante dans l'utérus (**nidation**), la grossesse débute et les règles n'ont pas lieu.
- S'il n'y a pas fécondation, les taux d'oestrogènes et de progestérone **diminuent**, l'endomètre se détache et de nouvelles règles commencent : un nouveau cycle débute.



Endométriose

L'endométriose est une maladie chronique qui se manifeste par le **développement anormal** d'un tissu semblable à **l'endomètre** sur les autres organes, tels qu'à l'extérieur de l'utérus, sur les ovaires, le péritoine, la vessie...

Même si cette pathologie reste encore un mystère du domaine médical féminin, elle touche environ 1 femme sur 10.

Plusieurs hypothèses sont maintenant proposées :

- reflux des règles vers les trompes
- facteur immunitaire
- facteur génétique
- facteur hormonal

Symptômes

Douleurs pelviennes chroniques, parfois douleurs lombaires

Dysménorrhées
(douleurs intenses lors des menstruations)

Dysurie
(douleur ou difficultés mictionnelles)

Dyspareunie
(douleur pendant ou après relation sexuelle)

Aucun traitement curatif n'est proposé jusqu'à présent. La prise en charge d'une patiente atteinte de cette pathologie repose surtout sur les **antalgiques**, les traitements **hormonaux** afin de réduire la croissance anarchique de l'endomètre, et dans certains cas la **chirurgie** est envisagée.

Ces femmes ont besoin de reconnaissance de leurs pathologie, il est important de ne pas minimiser ces douleurs !

